DIRETRIZES TÉCNICAS E PROPEDÊUTICA FEBRASGO

TRATADO DE PUERPÉRIO NORMAL, FISIOLOGIA DA LACTAÇÃO E INTERCORRÊNCIAS

Manual de Involução Genital, Semiotécnica Láctea, Contracepção e Condutas

A assistência ao puerpério e à lactação representa um dos pilares fundamentais da obstetrícia e da medicina materno-infantil. O puerpério é definido como o período dinâmico no qual o organismo materno passa por intensas modificações anátomo-fisiológicas, hormonais, metabólicas e psíquicas com o objetivo de retornar ao estado pré-gravídico e consolidar a lactação. O manejo adequado desse período exige do médico o domínio absoluto da diferenciação entre os fenômenos involutivos fisiológicos e as manifestações patológicas precoces, prevenindo complicações graves e garantindo o sucesso do aleitamento materno exclusivo.

---

1. Definição, Conceitos e Divisão Cronológica do Puerpério

O puerpério (também denominado pós-parto ou sobreparto) inicia-se imediatamente após o término do quarto período do parto (dequitadura placentária e consolidação da hemostasia uterina) e estende-se por um período médio de 6 a 8 semanas (42 a 56 dias). Do ponto de vista didático e semiológico, as diretrizes da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) e a literatura obstétrica dividem o puerpério em três fases cronológicas distintas:

DINÂMICA E CRONOLOGIA DO PUERPÉRIO

[Parto / Dequitadura] ■■■ [Puerpério Imediato] ■■■ [Puerpério Tardio] ■■■ [Puerpério Remoto]

(1º ao 10º Dia)	(11º ao 45º Dia)	(Além do 45º Dia)
■	■	■
- Hemostasia (Greenberg)	- Regeneração endometrial	- Retorno da função
- Involução uterina rápida	- Lóquios flava/alba	ovariana / mênstruo
- Apojadura (2º–5º dia)	- Restauração vaginal	- Adaptação metabólica

1.1 Puerpério Imediato (1º ao 10º Dia Pós-Parto)

Compreende os primeiros dez dias subsequentes ao nascimento. É a fase de maior instabilidade hemodinâmica e metabólica, onde ocorrem os fenômenos involutivos mais intensos. A primeira hora pós-parto (inserida no Quarto Período do Parto ou Período de Greenberg) é crítica para o controle da hemostasia uterina por meio do miotamponamento (Ligaduras de Pinard) e trombotamponamento. Ocorre a consolidação do Globo de Segurança de Pinard e o surgimento da apojadura (descida do leite) entre o 2º e o 5º dia pós-parto.

1.2 Puerpério Tardio (11º ao 45º Dia Pós-Parto)

Estende-se do 11º até o 45º dia pós-parto. Caracteriza-se pela regressão gradual dos órgãos genitais internos e externos, cicatrização e regeneração do estroma e glândulas endometriais (com epitelização da cavidade uterina por volta do 25º dia), e modificação do aspecto da loquiação para tons amarelados/esbranquiçados (*lochia flava/alba*).

1.3 Puerpério Remoto (A partir do 45º Dia Pós-Parto)

Inicia-se a partir do 46º dia e estende-se indeterminadamente até o retorno completo da função ovariana cíclica e do padrão menstrual, que é altamente variável a depender da presença, intensidade e frequência do aleitamento materno. Em puérperas não lactantes, a ovulação e a menstruação reaparecem habitualmente entre 6 e 8 semanas pós-parto.

---

2. Manifestações Involutivas e Fisiológicas do Aparelho Genital

2.1 Involução Uterina e Reorganização do Miométrio

O corpo uterino passa por um processo impressionante de regressão hiperplásica e hipertrófica. Imediatamente após a saída da placenta, o útero contrai-se fortemente e seu fundo situa-se na altura da cicatriz umbilical (ou 1 a 2 cm abaixo dela), apresentando peso aproximado de 1.000 g.

• **Taxa de Regressão:** O fundo uterino regride a uma taxa média de **1 cm a 2 cm por dia** (aproximadamente um través de dedo por dia).

• **Posição Pélvica:** Por volta do **10º ao 12º dia pós-parto**, o fundo uterino deixa de ser palpável abdominalmente, intrapelvisando-se atrás da sínfise púbica.

• **Massa Final:** Ao final da 6ª semana puerperal, o útero retorna às suas dimensões pré-gravídicas normais, pesando cerca de 60 g a 80 g.

• **Efeito da Amamentação (Reflexo Uteromamário):** Durante a sucção do recém-nascido, a liberação pulsátil de ocitocina pela neuro-hipófise provoca contrações uterinas vigorosas (conhecidas como "cólicas de amamentação" ou *pânfagos*), acelerando significativamente a taxa de involução uterina em lactantes (percebidas com maior intensidade nas multíparas).

DINÂMICA E CRONOLOGIA DO PUERPÉRIO

[Pós-Parto Imediato] ■■■■■■■ Fundo Uterino na Cicatriz Umbilical (~1.000 g)
[1º ao 5º Dia] ■■■■■■■ Regressão de 1 cm/dia (Palpável no hipogástrio)
[10º ao 12º Dia] ■■■■■■■ Intrapelvisação (Não mais palpável no abdome; ~500 g)
[6ª Semana] ■■■■■■■ Retorno às dimensões normais pré-gravídicas (~60–80 g)

2.2 Regeneração Endometrial e Leito Placentário

A descamação e separação da placenta ocorrem na camada esponjosa da decídua. O endométrio puerperal divide-se em duas camadas: uma camada superficial (que sofre necrose e é expelida nos lóquios) e uma camada basal profunda (preservada, contendo os fundos de saco glandulares e o estroma denso).

• A regeneração do endométrio geral conclui-se por volta do **25º dia pós-parto**.

• A regeneração do leito placentário (onde ocorre trombose dos vasos espiralados e reestruturação vascular) é mais lenta, completando-se apenas ao final da **6ª semana**.

2.3 Colo Uterino, Vagina e Períneo

• **Colo Uterino:** No pós-parto imediato, o colo apresenta-se flácido, edemaciado e dilatado. O orifício cervical interno (OCI) fecha-se gradualmente, permitindo a passagem de apenas um dedo no 3º ao 4º dia, e encontrando-se impenetrável ao final da 2ª semana. O orifício cervical externo (OCE) fecha-se mais lentamente e adquire a forma definitiva de fenda transversal (típica da mulher parida), diferenciando-se do orifício pontiforme da nulípara.

• **Vagina e Vulva:** O epitélio vaginal apresenta-se hipotrófico/atrófico nos primeiros dias devido ao estresse e à queda abrupta do estrogênio. As rugosidades vaginais reaparecem por volta da 3ª à 4ª semana, mas a elasticidade total é recuperada ao final do puerpério. Em lactantes, a hiperprolactinemia mantém um estado de hipoestrogenismo prolongado, resultando em atrofia vaginal persistente, ressecamento e dispareunia de intróito.

2.4 Dinâmica e Características da Loquiação (Lóquios)

Lóquios são o exsudato uterino composto por eritrócitos, restos de decídua, células epiteliais, mofo, muco cervical e bactérias da flora vaginal fisiológica. O volume total expelido varia entre 200 e 500 mL. A evolução macroscópica da loquiação segue um padrão cronológico estrito:

Tipo de Lóquio	Intervalo Pós-Parto	Composição Predominante	Aspecto Macroscópico
Lóquios Rubra (Cruentos)	1º ao 3º dia	Sangue de mofo, eritrócitos, fragmentos teciduais de decídua e muco	Vermelho-vivo / sangrento
Lóquios Fusca (Serossanguinolentos)	4º ao 10º dia	Exsudato seroso, leucócitos, eritrócitos hemolisados e muco	Acastanhado / rosado / fúscico
Lóquios Flava (Amarelados)	11º ao 20º dia	Leucócitos abundantes, células epiteliais, muco e bactérias	Amarelado / creme
Lóquios Alba (Brancos)	A partir do 21º dia até 4ª–6ª sem	Secreção mucosa transparente/esbranquiçada e restos celulares	Branco / esbranquiçado

• **Característica Odorífera Fisiológica:** A loquiação normal possui odor característico de sangue fresco ou líquido seminal ("odor de esperma"). **A presença de odor fétido ou purulento (associado ou não a febre e dor uterina à palpação) é sinal patológico patognomônico de Infecção Puerperal / Endometrite.**

---

3. Involução e Reorganização dos Sistemas Extragenitais

3.1 Sistema Cardiovascular e Hemodinâmica Puerperal

• **Autotransfusão Fisiológica:** Logo após o descolamento placentário e a contração uterina, ocorre a mobilização de cerca de 500 mL a 1.000 mL de sangue da circulação uteroplacentária de volta para o leito vascular sistêmico materno, gerando um aumento transitório da pré-carga e do débito cardíaco na primeira hora pós-parto.

• **Redistribuição hídrica:** Entre o **3º e o 6º dia pós-parto**, ocorre reabsorção maciça do fluido intersticial acumulado na gestação (até 6 a 8 litros de água e 950 mEq de sódio) para o intravascular. Isso leva a uma diurese e sudorese profundas.

• **Ajuste Pressórico:** Pode haver oscilação dos níveis de pressão arterial. Em portadoras de pré-eclâmpsia ou hipertensão crônica, a redistribuição volêmica entre o 3º e 6º dia pode desencadear **picos hipertensivos graves e edema agudo de pulmão**, exigindo monitorização rigorosa. O débito cardíaco e a frequência cardíaca retornam ao basal pré-gravídico entre 2 e 6 semanas.

3.2 Sistema Hematológico, Leucocitose e Hipercoagulabilidade

• **Anemia Fisiológica x Hemostasia:** A perda sanguínea média considerada fisiológica é de até 500 mL no parto vaginal e até 1.000 mL na cesariana.

• **Leucocitose Puerperal Fisiológica:** Ocorre intensa mobilização leucocitária, atingindo contagens de **15.000/mm³ a 25.000/mm³ no pós-parto imediato**, com predomínio de granulócitos maduros, **sem desvio à esquerda**. Esse achado é fisiológico (resposta ao estresse do parto) e não deve ser confundido isoladamente com sepsis ou infecção.

• **Estado de Hipercoagulabilidade Mantedo:** O fibrinogênio, Fator VIII, Fator IX e a agregação plaquetária permanecem elevados durante as primeiras 2 a 6 semanas pós-parto. A atividade fibrinolítica plasminogênica continua deprimida. **O risco de Tromboembolismo Venoso (TEV) e Trombose Venosa Profunda (TVP) é de 5 a 10 vezes maior no puerpério do que fora da gestação**, atingindo o pico nos primeiros 14 dias.

3.3 Trato Urinário, Gastrointestinal e Pele

• **Bexiga e Trato Urinário:** O trauma do parto sobre a base vesical e o colo uterino, associado à insensibilidade nervosa por analgesia, reduz o tônus vesical, podendo levar a retenção urinária aguda e sobrefluxo (bexigoma). A dilatação fisiológica dos ureteres e pelves renais (hidronefrose fisiológica) regride completamente em 6 a 8 semanas.

• **Trato Gastrointestinal:** Ocorre reacomodação imediata das alças intestinais no abdome. A motilidade intestinal permanece reduzida nos primeiros dias devido à progesterona residual, dor perineal/episiotomia ou jejum pós-operatório, favorecendo a constipação.

• **Pele e Parede Abdominal:** Ocorre atenuação progressiva da hiperpigmentação (*linea nigra*, melasma) pela queda rápida do MSH e dos esteroides. As estrias arroxeadas (*striae rubrae*) involuem para tons pálidos e branco-nacarados (*striae albae*). A parede abdominal apresenta flacidez e diástase dos retos abdominais que recupera o tônus gradativamente em meses.

---

4. Fisiologia da Lactação: Mamogênese, Lactogênese e Lactopoese

A lactação é o processo neuroendócrino altamente especializado dividido didaticamente em quatro fases integradas: Mamogênese, Lactogênese, Lactopoese e Ejeção Láctea.

DINÂMICA E CRONOLOGIA DO PUERPÉRIO

[MAMOGÊNESE] ■■■ Desenvolvimento e maturação ductolobular (Estrogênio, Progesterona, hPL, PRL)

■

[LACTOGÊNESE] ■■■ Fase I (Início da secreção glandular na gestação - Colostro)

■ Fase II (Apojadura/Descida do Leite no 2º-5º dia pós-parto por queda do E2/P4)

■

[LACTOPOESE] ■■■ Manutenção da produção dependente da sucção e esvaziamento (Prolactina)

■

[EJEÇÃO LÁCTEA]■■ Contração mioepitelial alveolar estimulada por arcos reflexos (Ocitocina)

4.1 Mamogênese (Desenvolvimento Mamário)

Inicia-se na puberdade e atinge a maturação completa durante a gestação sob estímulo hormonal combinado:

• **Estrogênio:** Estimula a proliferação ductal e a ramificação da árvore galactófora.

• **Progesterona:** Promove o crescimento e diferenciação dos alvéolos e lóbulos mamários.

• **Prolactina (PRL), hPL, Cortisol e Insulina:** Promovem a maturação funcional e estrutural das Unidades Ductolobulares Terminais (UDLT).

4.2 Lactogênese (Gênese da Secreção Láctea)

• **Lactogênese Fase I (Colostrogênese):** Ocorre a partir da metade da gestação (por volta da 16ª–20ª semana). As células alveolares diferenciam-se e iniciam a síntese de colostro. No entanto, a produção volumosa de leite é **inibida quimicamente** pelos altos níveis de estrogênio e progesterona placentários, que bloqueiam a ação da prolactina nos receptores mamários.

• **Lactogênese Fase II (Apojadura / Descida do Leite):** Ocorre entre o **2º e o 5º dia pós-parto** (média de 72 horas). A saída da placenta e a cessação do hPL provocam uma queda abrupta e massiva dos níveis de estrogênio e progesterona. Com a remoção do freio esteroide, a Prolactina atua livremente sobre os alvéolos mamários.

* **Sinais da Apojadura:** Aumento do volume, peso e firmeza das mamas, ingurgitamento vascular/linfático, calor local e a chamada "Febre do Leite" (elevação térmica axilar transitória < 38,0 °C, durando menos de 24 horas, sem sinais infecciosos).

4.3 Lactopoese e Ejeção Láctea (Manutenção da Lactação)

A manutenção continuada da produção de leite (Lactopoese) depende do arco-reflexo neuroendócrino acionado pelo estímulo tátil de sucção do recém-nascido e pelo esvaziamento alveolar regular.

FLUXOGRAMA / ESQUEMA CONCEITUAL

[Estimulo Tátil na Aréola / Mamilo] ■■■ Impulsos Nervosos para o Hipotálamo

■

**■■■

1. **Prolactina (Adeno-hipófise):** Estimula as células epiteliais alveolares a sintetizar proteína (caseína), lactose e lipídios. A prolactina apresenta picos de secreção 30 minutos após cada mamada, garantindo a produção de leite para a mamada seguinte. Apresenta pico máximo durante a noite.

2. **Ocitocina (Neuro-hipófise):** Estimulada pela sucção (e por estímulos visuais, auditivos e emocionais), é secretada em pulsos e provoca a contração das **células mioepiteliais** que envolvem os alvéolos mamários, ejetando o leite pelos ductos galactóforos. Provoca também o reflexo uteromamário (contração do miométrio).

4.4 Composição do Leite Materno: Colostro x Leite Maduro x Leite de Vaca

O leite materno é espécie-específico e evolui dinamicamente em sua composição ao longo das semanas de amamentação e durante a própria mamada:

Componente	Colostro (1º ao 5º Dia)	Leite Maduro (Pós-15º Dia)	Leite de Vaca Integral
Aspecto e Densidade	Amarelado, espesso, alta densidade	Fluido, opalescente/esbranquiçado	Branco, denso
Proteínas Totais	**Elevado (~6,0%)**	**Adequado (~1,0% a 1,2%)**	**Excessivo (~3,5%)**
Relação Soro / Caseína	**80 : 20** (Fácil digestão)	**60 : 40** (Digestão ideal)	**20 : 80** (Curd denso/difícil)
Carboidratos (Lactose)	~3,0%	**Elevado (~7,0%)**	~4,5%
Gorduras / Lipídios	~2,5%	**~3,5% a 4,5%**	~3,5%
Imunoglobulinas / IgA	**Altíssima concentração (IgAs)**	Concentração moderada	Ausente / Irrelevante
Biodisponibilidade Ferro	Alta	**~50% de absorção**	**~10% de absorção**

• **Diferença entre Leite Anterior e Leite Posterior na Mamada:**

* **Leite Anterior (Início da Mamada):** Rico em água, lactose, proteínas e imunoglobulinas. Tem função primordial de hidratar o bebê e fornecer imunidade.

* **Leite Posterior (Final da Mamada):** Rico em **gorduras e ácidos graxos de cadeia longa (lipídios)**. É responsável pela saciedade do recém-nascido e ganho de peso ponderal. **É fundamental garantir o esvaziamento completo de uma mama antes de oferecer a outra.**

---

5. Técnica e Semiotécnica da Amamentação

O insucesso na amamentação decorre, na grande maioria das vezes, de falhas no posicionamento e na técnica de pega, e não de insuficiência glandular primária ("leite fraco" ou "pouco leite" são mitos sociais).

5.1 Critérios de Posicionamento e Pega Correta

SEMIOTÉCNICA DA PEGA CORRETA

[Pega Correta] ■■■ Boca bem aberta ("peixinho") + Lábios evertidos + Aréola mais visível acima + Queixo encostado na mama + Bochechas arre

1. **Posicionamento da Dupla Mãe-Bebê:**

* Corpo do bebê totalmente voltado para o corpo da mãe ("barriga com barriga").

* Cabeça e tronco do bebê alinhados no mesmo eixo longitudinal.

* Rosto do bebê de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo.

* Mãe relaxada, confortável e com apoio adequado para as costas e braços.

2. **Sinais de Pega Correta (Pega Eficaz):**

* Boca do bebê bem aberta (ângulo > 120° / boca de "peixinho").

* Lábios evertidos (virados para fora), especialmente o lábio inferior.

* Queixo do bebê encostado firmemente na mama materna.

* Aréola mais visível **acima da boca do bebê do que abaixo dela** (pega assimétrica).

* Bochechas arredondadas e cheias durante a sucção (sem covinhas ou estalidos).

* Sucção rítmica: padrão de sucção - pausa - deglutição (auditivamente perceptível).

3. **Recomendações Práticas Fundamentais:**

* **Livre Demanda:** O bebê deve mamar sem rigidez de horários ou duração, sempre que demonstrar sinais precoces de fome (movimentos de busca, levar mãos à boca).

* **Abolição de Bicos Artificiais e Chupetas:** Cusam "confusão de bicos" e alteram a motilidade orofacial.

* **Proibição de Pomadas / Cremes Mamilares Rotineiros:** Não há indicação profilática. A melhor proteção para o mamilo é a aplicação de gotas do próprio leite materno após as mamadas.

---

6. Intercorrências Benignas e Complicações na Lactação

6.1 Fissura Mamilo-Areolar

• **Etiopatogenia:** Lesão traumática do epitélio do mamilo/aréola decorrente quase exclusivamente de **pega e posicionamento incorretos** ou fricção mecânica por bombas de ordenha inadequadas.

• **Quadro Clínico:** Dor intensa e dilacerante no momento da pega e durante a amamentação, solução de continuidade/fissura visível e sangramento eventual.

• **Manejo Clínico:**

* **Correção Imediata da Pega e Posicionamento:** Medida terapêutica central e definitiva.

* **Manutenção da Amamentação:** Não interromper o aleitamento. Iniciar a mamada pela mama menos dolorosa.

* **Proteção Epitelial:** Ordenhar gotas do próprio leite e passar na aréola/mamilo após as mamadas; exposição das mamas à luz solar direta (banho de sol por 15 min antes das 10h ou após 16h) ou luz artificial. Proibir sabões, álcool ou pomadas espessas que exijam fricção para remoção.

6.2 Ingurgitamento Mamário (Fisiológico x Patológico)

• **Etiopatogenia:** Acúmulo excessivo de leite nos alvéolos associado a edema e estase vascular/linfática. Ocorre por atraso no início da amamentação, pega ineficaz, restrição de horários ou retenção láctea.

• **Classificação:**

* **Ingurgitamento Glandular:** Aumento de volume por retenção pura de leite (mama cheia, mas macia e facilmente ordenhável).

* **Ingurgitamento Patológico (Vascular e Tissular):** Mama excessivamente distendida, endurecida, brilhante, eritematosa, com dor difusa e edema areolar intenso que planifica o mamilo e impede a pega do bebê.

• **Manejo Clínico:**

* **Massagem Circular e Ordenha Manual Prévia:** Massagens circulares suaves a partir da aréola para desobstruir os ductos e ordenha manual do alvéolo areolar para amolecer a região retroareolar antes de oferecer a mama ao bebê.

* **Amamentação Frequente em Livre Demanda.**

* **Compressas Frias Tópicas (Gelo ou Gel):** Aplicadas por 10 a 15 minutos **APÓS as mamadas ou ordenhas** para promover vasoconstrição local e reduzir o edema tissular. (Nunca aplicar calor na mama ingurgitada, pois a vasodilatação piora o edema!).

6.3 Mastite Lactacional Puerperal

• **Etiopatogenia:** Processo inflamatório e infeccioso do parênquima mamário. A porta de entrada costuma ser uma fissura mamilar, e o agente etiológico mais comum é o ***Staphylococcus aureus*** (frequentemente proveniente da nasofaringe do recém-nascido ou flora cutânea materna), seguido por *Streptococcus* e *E. coli*.

• **Quadro Clínico:**

* Sinais flogísticos localizados e setorizados em um quadrante mamário: **eritema em cunha/setor, calor, edema e dor intensa**.

* Sinais sistêmicos de infecção: **febre alta (> 38,0 °C), calafrios, astenia, mialgia e taquicardia**.

• **Manejo Clínico Específico:**

* **NÃO SUSPENDER A AMAMENTAÇÃO:** É o erro médico mais grave. O esvaziamento continuo da mama afetada é essencial para a cura e previne a evolução para abscesso. O leite da mama com mastite não faz mal ao bebê.

* **Sintomáticos:** Analgésicos (Paracetamol, Dipirona) e Anti-inflamatórios não esteroides (Ibuprofeno).

* **Antibioticoterapia Sistêmica (por 7 a 10 dias):** Indicada quando há febre, piora dos sintomas locais ou fissura infectada.

* Primeira linha: **Cefalexina 500 mg VO de 6/6 horas**; ou **Amoxicilina + Clavulanato 875/125 mg VO de 12/12 horas**; ou **Cloxacilina 500 mg VO de 6/6 horas**.

* Em alérgicas à penicilina: Clindamicina 300 mg VO de 6/6 horas ou Eritromicina.

6.4 Abscesso Mamário Puerperal

• **Etiopatogenia:** Complicação não tratada ou negligenciada de uma mastite lactacional, caracterizada pela formação de coleção purulenta focal delimitada.

• **Quadro Clínico:** Área flutuante, dolorosa, edemaciada e eritematosa na mama, febre persistente e calafrios a despeito do uso de antibióticos. O diagnóstico é confirmado por Ultrassonografia Mamária.

• **Manejo Clínico:**

* **Esvaziamento do Abscesso:** Drenagem cirúrgica aberta ou Puncional aspirativa guiada por Ultrassonografia (preferencial por ser menos invasiva e esteticamente superior).

* **Antibioticoterapia Sistêmica Parenteral ou Oral de Amplo Espectro.**

* **Conduta quanto à Amamentação:** Manter a amamentação na mama saudável. Na mama afetada, a amamentação deve ser mantida **desde que a drenagem ou incisão cirúrgica não esteja próxima da aréola/mamilo e não haja drenagem espontânea de pus pelos óstios galactóforos**. Se a amamentação direta estiver contraindicada temporariamente na mama doentia, deve-se realizar **ordenha manual ou mecânica suave contínua** para evitar a estase.

6.5 Fenômeno de Raynaud do Mamilo

• **Etiopatogenia:** Vasospasmo paroxístico dos vasos sanguíneos do mamilo, desencadeado por trauma mamilar (má pega) ou exposição ao frio.

• **Quadro Clínico:** Dor trifásica intensa em agulhada ou queimação no mamilo após as mamadas, acompanhada de **palidez isquêmica esbranquiçada focal no mamilo, seguida de cianose (arroxeado) e hiperemia reativa (vermelho)**.

• **Manejo Clínico:** Correção da pega, aplicação de calor seco local imediatamente após a mamada e, nos casos refratários e graves, uso de bloqueadores dos canais de cálcio (**Nifedipino 10 mg a 20 mg VO de 8/8 horas**).

6.6 Inibição da Lactação (Farmacológica e Não-Farmacológica)

• **Indicações Formais:** Óbito fetal/neonatal, Mães Vivendo com HIV ou HTLV-1/2, uso de medicamentos antineoplásicos/radioativos e psicoses puerperais graves.

• **Método Não-Farmacológico:**

* Compressão mamária contínua com sutiã de sustentação firme ou faixa mamária (por 7 a 10 dias).

* Aplicação de bolsas de gelo locais (10 a 15 minutos, 4 vezes ao dia).

* Ausência absoluta de estímulo tátil ou ordenha.

• **Método Farmacológico (Tratamento de Escolha):**

* **Cabergolina (Dopaminérgico Seletivo): 1,0 mg VO em dose única** (2 comprimidos de 0,5 mg administrados no primeiro dia pós-parto). Em casos de inibição tardia (lactação já estabelecida), utiliza-se Cabergolina 0,25 mg VO de 12/12 horas por 2 dias (dose total de 1,0 mg).

Ressalva:* A Bromocriptina não é mais recomendada pela FEBRASGO e ANVISA para inibição da lactação devido ao risco de AVC, infarto do miocárdio e crises hipertensivas.

---

7. Assistência Pós-Natal e Contracepção no Puerpério

7.1 Rotina de Avaliação Clínica no Pós-Parto

O acompanhamento da puérpera deve ser sistematizado na maternidade e mantido no ambulatório de Atenção Básica:

1. **Exame Diário na Maternidade (até a alta):**

* Avaliação de Sinais Vitais (PA, FC, FR, Temperatura axilar).

* Palpação abdominal e avaliação da altura e consistência do fundo uterino (Globo de Pinard).

* Inspeção dos Lóquios (quantidade, cor, odor).

* Exame das Mamas (apojadura, presença de fissuras, pega).

* Inspeção do Períneo (episiotomia, lacerações) ou da Ferida Operatória da Cesariana.

* Exame dos Membros Inferiores (sinais de TVP: dor à dorsiflexão do pé - Sinal de Homans, edema de panturrilha e empastamento).

2. **Cronograma de Consultas Pós-Natais na Atenção Básica:**

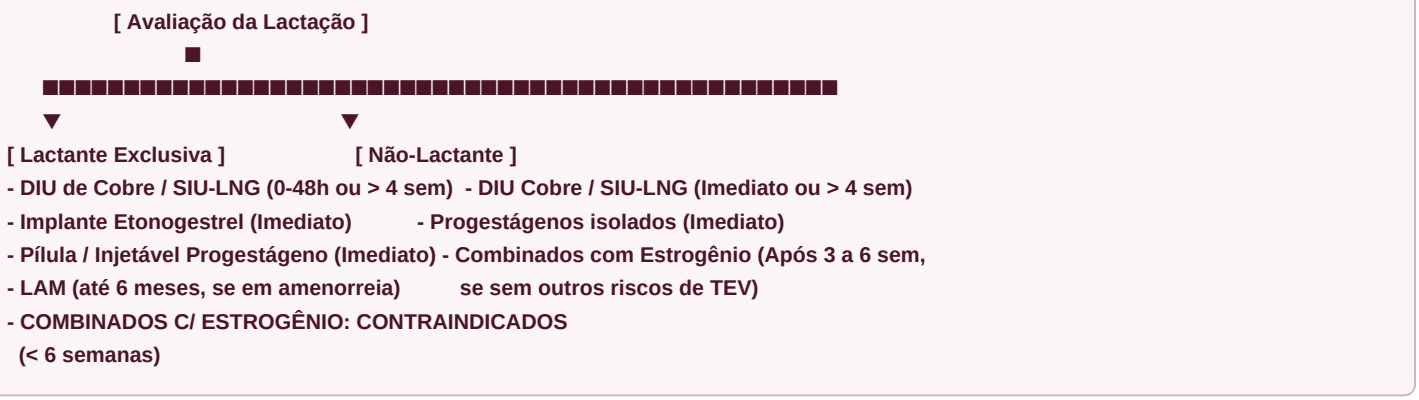
* **1ª Consulta:** Entre o **7º e o 10º dia pós-parto** (avaliação conjunta da puérpera e do recém-nascido na "Primeira Semana de Saúde Integral").

* **2ª Consulta:** Ao final da **6ª semana puerperal (~42 dias pós-parto)** para revisão geral, alta do puerpério e consolidação do método contraceptivo.

7.2 Contracepção no Puerpério (Critérios de Elegibilidade FEBRASGO / OMS)

A escolha do método contraceptivo no pós-parto deve considerar o estado de amamentação, o tempo decorrido desde o parto e o risco de tromboembolismo venoso:

FLUXOGRAMA / ESQUEMA CONCEITUAL



Método Contraceptivo	Categoria OMS em Lactantes (< 6 Semanas)	Categoria OMS em Lactantes (> 6 Semanas a 6 Meses)	Recomendação e Conduta Clínica no Pós-Parto
DIU de Cobre / SIU-LNG	**Categoria 1 / 2**	**Categoria 1**	Inserção imediata (nas primeiras 48h pós-parto) ou atrasada após 4 a 6 semanas.
Implante de Etonogestrel	**Categoria 1 / 2**	**Categoria 1**	Altíssima eficácia; pode ser inserido no pós-parto imediato antes da alta.
Pílula de Progestágeno (Minipílula / Desogestrel)	**Categoria 2** (OMS) / **Cat 1** (CDC)	**Categoria 1**	Início imediato ou em 6 semanas. Não interfere no volume ou qualidade do leite.
Injetável Trimestral (Medroxiprogesterona)	**Categoria 2 ou 3**	**Categoria 1**	Preferir iniciar após 6 semanas em lactantes para evitar passagem hormonal precoce no leite.
Contraceptivos Combinados (Estrogênio + Progesterona)	**CATEGORIA 4 (CONTRAINDICADO)**	**CATEGORIA 3 / 4 (CONTRAINDICADO)**	**O estrogênio reduz a produção de leite e aumenta drasticamente o risco de TEV no puerpério.** Liberado apenas após 6 meses se em amamentação exclusiva.
Método da Amenorreia da Lactação (LAM)	Eficácia de ~98%	Eficácia reduzida se introduzir alimentos	Válido apenas se: (1) Amamentação exclusiva em livre demanda; (2) Puérpera em amenorreia; (3) Bebê < 6 meses.

---

8. Sinais de Alerta e Síndromes Patológicas do Puerpério

A diferenciação rápida entre alterações fisiológicas e síndromes patológicas é vital:

SINAIS DE ALERTA PUERPERAL

[Sinal de Alerta Puerperal]

- ■
- ■■■■ **Febre + Lóquios Fétidos + Dor Uterina** ■■■■■■■ **ENDOMETRITE PUERPERAL**
- ■■■■ **Hemorragia Vulvar Abundante com Coágulos** ■■■■ **RETENÇÃO DE RESTOS / ATONIA TARDIA**
- ■■■■ **Eritema Mamário Setorizado + Febre** ■■■■■■■■■■ **MASTITE LACTACIONAL**
- ■■■■ **Edema Assimétrico de Panturrilha + Dor** ■■■■■■■ **TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP)**
- ■■■■ **Cefaleia Intensa + Escotomas + PA ≥ 140/90** ■■■ **PRÉ-ECLÂMPSIA / ECLÂMPSIA PUERPERAL**

8.1 Endometrite Puerperal (Infecção Puerperal)

• **Conceito:** Infecção polimicrobiana ascendente da cavidade uterina (envolvendo anaeróbios, *Streptococcus*, *E. coli*, *G. vaginalis*). O principal fator de risco é a **cesariana** (risco 10 a 20 vezes maior do que no parto vaginal).

• **Tríade Patognomônica: Febre (≥ 38,0 °C no 2º dia consecutivo) + Dor abdominal/uterina à palpação (Sinal de Bumm: útero subinvoluído, amolecido e doloroso) + Lóquios fétidos ou purulentos**.

• **Tratamento Hospitalar Padrão-Ouro:** Esquema parenteral com **Clindamicina (900 mg IV de 8/8h) + Gentamicina (5 mg/kg IV 1x/dia)** até a paciente permanecer afebril e assintomática por 48 horas.

8.2 Transtornos Psiquiátricos do Puerpério

• **Disforia Pós-Parto (*Baby Blues* ou *Blues* Puerperal):**

* Ocorre em até **60% a 80% das puérperas**.

* Instala-se entre o 3º e 5º dia pós-parto e dura no máximo **2 semanas**.

* Sintomas leves: labilidade emocional, choro fácil, ansiedade e irritabilidade, sem prejuízo no cuidado com o bebê.

* Conduta: Fisiológico e autolimitado. Suporte emocional e acolhimento familiar.

• **Depressão Pós-Parto (DPP):**

* Atinge 10% a 20% das mulheres. Instala-se habitualmente entre a 2ª e a 6ª semana.

* Sintomas graves: anedonia, tristeza profunda, sentimentos de incapacidade e rejeição ao bebê, insônia grave.

* Conduta: Psicoterapia e Antidepressivos (Sertralina 50 a 100 mg/dia é a droga de escolha por apresentar baixíssima excreção no leite materno).

• **Psicose Puerperal:**

* Emergência psiquiátrica rara (0,1% a 0,2%).

* Quadro agudo nos primeiros 14 dias com delírios, alucinações, confusão mental e risco iminente de infanticídio ou suicídio.

* Conduta: Internação psiquiátrica imediata, antipsicóticos e afastamento temporário do bebê sob supervisão.

---

9. Série de 10 Casos Clínicos Práticos e Ilustrativos

Caso 1: Puerpério Imediato Fisiológico e Avaliação de Involução Uterina

• **História Clínica:** Puérpera de 24 anos, primípara, no 3º dia pós-parto vaginal sem intercorrências, comparece à visita enfermaria. Relata cólicas intensas no pé do abdome durante as mamadas e eliminação de secreção avermelhada pelo canal vaginal sem odor desagradável.

• **Exame Físico:** Lóquios rubra em quantidade moderada sem fetidez. Fundo uterino palpável e firme no hipogástrio, 3 cm abaixo da cicatriz umbilical. Mamas simétricas, túrgidas, dolorosas difusamente, sem eritema focal, secretando colostro espesso amarelado à expressão.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Trata-se de um puerpério imediato fisiológico. A dor abdominal em cólica durante as mamadas decorre da liberação de ocitocina (reflexo uteromamário). A altura uterina e os lóquios rubra estão perfeitamente adequados para o 3º dia. Conduta: Orientar sobre a fisiologia do processo involutivo, manter analgésicos simples (Dipirona) se necessário e incentivar o aleitamento materno exclusivo em livre demanda.

Caso 2: Apojadura Fisiológica ("Febre do Leite") x Mastite Puerperal

• **História Clínica:** Primípara de 28 anos, 3º dia pós-parto cesárea, relata que há 12 horas as mamas ficaram "muito cheias, quentes e duras", notando pico febril de 37,8 °C axilar há 4 horas. Sem queixas urinárias, respiratórias ou dor na ferida operatória.

• **Exame Físico:** PA 120x78 mmHg, FC 82 bpm, Temperatura 37,6 °C. Mamas bilateralmente ingurgitadas, endurecidas, hiperemiadas difusamente e dolorosas à palpação global. Ausência de áreas de eritema setorizado em cunha, flutuação ou fissuras mamilares. Útero contraído, lóquios rubra fisiológicos.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Quadro clássico de **Apojadura Fisiológica (Descida do Leite)** acompanhada da "Febre do Leite" (febre febrícula transitória < 38,0 °C por ingurgitamento vascular/linfático). Não há evidência de mastite (ausência de febre alta persistente, ausência de eritema setorizado em cunha e ausência de fissuras). Conduta: Tranquilizar a paciente, orientar massagens circulares e ordenha areolar prévia à mamada, incentivar mamadas frequentes e aplicar compressas frias locais APÓS as mamadas. Prescrever analgesia simples e alta hospitalar.

Caso 3: Fissura Mamilo-Areolar por Má Pega e Semiotécnica da Amamentação

• **História Clínica:** Puérpera de 19 anos, 8º dia pós-parto, queixa-se de dor severa em mamilos durante as mamadas, relatando que "dá vontade de chorar quando o bebê pega o peito". Notou estrias de sangue nas fraldas do bebê após mamar.

• **Exame Físico:** Mamas macias. Presença de fissura linear ulcerada na base do mamilo direito e escoriação na mama esquerda. Durante a observação da mamada: o bebê apresenta boca pouco aberta, lábios para dentro (invertidos), bochechas encovadas produzindo estalidos, e abocanha apenas o mamilo.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Fissura mamilo-areolar secundária à técnica incorreta de pega (pega rasa exclusiva do mamilo). O sangue ingerido pelo bebê na fissura materna justifica a presença de sangue oculto/estrias nas fezes/vômito do RN. Conduta: **Não interromper a amamentação.** Realizar a correção guiada da pega e posicionamento (orientar abertura ampla da boca, lábio evertido e abocanhar a maior parte da aréola). Orientar passar o próprio leite materno no mamilo após as mamadas e exposição solar. Proibir o uso de pomadas sintéticas ou bicos de silicone.

Caso 4: Ingurgitamento Mamário Patológico e Manejo de Alívio

• **História Clínica:** Secundípara de 31 anos, 4º dia pós-parto, apresenta mamas extremamente dolorosas e endurecidas. Relata que o bebê não consegue pegar o peito porque a aréola está "muito dura e esticada", deixando o RN irritado e chorando.

• **Exame Físico:** Mamas bilateralmente muito ingurgitadas, brilhantes, edemaciadas e tensas. Região areolar plana e rígida. Ausência de febre ou sinais de abscesso.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Ingurgitamento mamário patológico (tissular e glandular). A rigidez da aréola impede a preensão pelo recém-nascido, criando um círculo vicioso de retenção láctea. Conduta: Ensinar e realizar a **Técnica de Ordenha Manual Areolar de Alívio (Pressão Positiva)**: a mãe deve pressionar a aréola com a ponta dos dedos em direção ao tórax para deslocar o edema e amolecer a aréola antes de oferecer o peito ao bebê. Aplicar compressas frias por 15 minutos pós-ordenha para vasoconstrição local.

Caso 5: Mastite Lactacional Puerperal com Indicação de Antibioticoterapia

• **História Clínica:** Puérpera de 26 anos, 18º dia pós-parto, procura pronto-socorro com febre de 38,9 °C, calafrios intensos, prostração e dor intensa na mama esquerda há 24 horas.

• **Exame Físico:** Mamas simétricas. Presença de eritema, calor e edema delimitado em forma de setor/cunha no quadrante superior lateral da mama esquerda. Mamilo escoriado. Ausência de pontos de flutuação tecidual à palpação.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Quadro típico de **Mastite Lactacional Puerperal por *Staphylococcus aureus*** na mama esquerda. Conduta: **Manter rigorosamente a amamentação em ambas as mamas (inclusive na mama afetada)**, pois o esvaziamento previne complicações como abscesso. Iniciar antibioticoterapia oral com **Cefalexina 500 mg VO de 6/6 horas por 10 dias** (ou Amoxicilina + Clavulanato), sintomáticos (Ibuprofeno/Dipirona) e correção da pega mamilar.

Caso 6: Abscesso Mamário Puerperal e Conduta Terapêutica

• **História Clínica:** Paciente de 22 anos, no 28º dia pós-parto, tratada para mastite há 5 dias com analgésicos sem melhora. Mantém febre diária de 38,5 °C e dor pulsátil na mama direita.

• **Exame Físico:** Mama direita com área eritematosa no quadrante inferior. À palpação, nota-se massa dolente de 4 cm com nítido sinal de flutuação central. Ultrassonografia confirma coleção anecoica espessa delimitada de 3,8 cm contendo debrispus.

• **Raciocínio Clínico e Conduta: Abscesso Mamário Puerperal** secundário a mastite não tratada com antibiótico. Conduta: Esvaziamento da coleção via **puncional aspirativa guiada por Ultrassonografia** (ou drenagem cirúrgica se refratário), envio do material para cultura/antibiograma, prescrição de antibioticoterapia sistêmica (Cefalexina ou Clindamicina se MRSA) e manutenção da amamentação na mama contralateral. Na mama afetada, manter aleitamento se a incisão/punção estiver distante do CAP e sem saída de pus pelos ductos; caso contrário, realizar esvaziamento por ordenha manual suave.

Caso 7: Contracepção Puerperal em Lactante e Seleção do Método

• **História Clínica:** Puérpera de 29 anos, em consulta de revisão do 42º dia pós-parto (6ª semana), amamentando exclusivamente seu bebê. Solicita prescrição de método anticoncepcional, relatando que sua mãe sugeriu retomar a pílula combinada que usava antes de engravidar.

• **Exame Físico:** Exame ginecológico normal, útero intrapélvico involuído, lóquios ausentes. PA 118x74 mmHg.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Os anticoncepcionais hormonais combinados (contendo estrogênio) são **contraindicados em lactantes (Categoria 3/4 da OMS)** por reduzirem o volume e a qualidade do leite materno e aumentarem o risco de TEV no puerpério. Opções indicadas: **Progestágenos isolados (Pílula de Desogestrel 75 mcg/dia, Implante de Etonogestrel ou Injetável Trimestral de Acetato de Medroxiprogesterona)** ou **DIU de Cobre / SIU de Levonorgestrel (Categoria 1)**. Optado pela inserção do DIU de Cobre no consultório.

Caso 8: Endometrite Puerperal Pós-Cesárea (Tríade Clássica)

• **História Clínica:** Paciente de 32 anos, 5º dia pós-operatório de cesárea de emergência por trabalho de parto prolongado e bolsa rota de 18 horas. Apresenta febre de 38,8 °C, calafrios e dor em cólica na região pélvica.

• **Exame Físico:** PA 110x70 mmHg, FC 104 bpm, Temp 38,6 °C. Abdome doloroso à palpação em hipogástrio. À palpação bimanual: útero amolecido, doloroso e subinvoluído (Sinal de Bumm). Exame especular: eliminação de lóquios purulentos de odor fétido pelo orifício cervical. Ferida operatória sem hiperemia ou secreções.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** Diagnóstico de **Endometrite Puerperal (Infecção Puerperal)**. O trabalho de parto prolongado, bolsa rota e cesárea são fatores de risco determinantes. Conduta: Internação hospitalar imediata, solicitação de hemoculturas e exames laboratoriais, e início do esquema antibiótico parenteral de primeira linha: **Clindamicina 900 mg IV de 8/8 horas + Gentamicina 5 mg/kg IV 1x/dia** até a paciente permanecer afebril e assintomática por 48 horas.

Caso 9: Disforia Pós-Parto (*Baby Blues*) x Depressão Pós-Parto

• **História Clínica:** Puérpera de 25 anos, no 5º dia pós-parto de seu primeiro filho, é trazida pelo marido. Ele relata que a esposa chora sem motivo aparente, diz que está insegura sobre como cuidar do bebê e apresenta labilidade emocional. A paciente mantém bom vínculo afetivo com o recém-nascido, amamenta adequadamente e dorme quando o bebê dorme.

• **Exame Físico:** Exame físico e obstétrico sem alterações. Teste para depressão sem escore para transtorno grave.

• **Raciocínio Clínico e Conduta: Disforia Pós-Parto (*Baby Blues*)**, condição fisiológica e transitória decorrente das flutuações hormonais abruptas e do estresse de adaptação materna. Não há prejuízo no vínculo ou autocuidado. Conduta: Acolhimento, suporte emocional, orientação à família e reavaliação em 2 semanas. Tranquilizar o casal informando que os sintomas regridem espontaneamente em até 14 dias sem necessidade de psicofármacos.

Caso 10: Inibição Farmacológica da Lactação em Mão Soropositiva para HIV

• **História Clínica:** Gestante de 27 anos, Mão Vivendo com HIV (em uso de TARV com carga viral indetectável), dá à luz por cesárea eletiva na 38ª semana. No pós-parto imediato (primeiras 2 horas), a equipe solicita conduta para inibição da lactação.

• **Exame Físico:** Puérpera hígida, mamas simétricas e macias.

• **Raciocínio Clínico e Conduta:** No Brasil, a infecção pelo HIV é **contraindicação absoluta para o aleitamento materno** devido ao risco de transmissão vertical pelo leite. Conduta:

• 1. Inibição não-farmacológica: enfaixamento suave ou uso de sutiã de sustentação firme.

• 2. Inibição farmacológica imediata: **Cabergolina 1,0 mg VO em dose única** (2 comprimidos de 0,5 mg administrados simultaneamente no pós-parto imediato).

• 3. Garantir a disponibilização de fórmula infantil láctea para o recém-nascido e orientar a não realização de "amamentação cruzada" (por outra mulher).

• ---

10. Matrizes e Tabelas Sinópticas para Memorização Rápida

10.1 Matriz de Involução Genital e Cronologia Puerperal

Parâmetro / Estrutura	Puerpério Imediato (1º–10ºd)	Puerpério Tardio (11º–45ºd)	Puerpério Remoto (> 45d)
Altura do Fundo Uterino	Na umbilical no 1ºd; regride 1 cm/dia	Intrapélvico (não palpável no 10º–12ºd)	Tamanho pré-gravídico normal (60–80 g)
Padrão da Loquiação	*Lóquios Rubra* (1º-3ºd) e *Fusca* (4º-10ºd)	*Lóquios Flava* e *Alba*	Ausente / Leucorreia fisiológica
Orifício Cervical Interno (OCI)	Admite 1 a 2 dedos no 1ºd; fecha no 3º–4ºd	Fechado e impenetrável	Fechado (OCE em fenda transversal)
Regeneração Endometrial	Camada basal preservada; necrose funcional	Concluída no 25ºd (leito no 42ºd)	Endométrio completamente reestruturado
Vagina e Músculos Pelvicos	Edemaciados e hipotróficos	Regressão das rugosidades no 15º–21ºd	Tônus parcial/total recuperado

10.2 Matriz Diagnóstica e Terapêutica das Intercorrências Mamárias

Patologia Mamária	Achados Clínicos Primários	Estado da Febre e Sinais Sistêmicos	Conduta quanto à Amamentação	Tratamento de Escolha
Fissura Mamilar	Ulceração/escoriação dolorosa no mamilo	Ausentes	**MANTER** em ambas as mamas	Correção da pega + próprio leite na lesão + sol
Ingurgitamento Patológico	Mamas edemaciadas, duras, aréola rígida	"Febre do leite" transitória (< 38°C)	**MANTER** após aliviar aréola	Ordenha areolar prévia + compressa FRIAS pós
Mastite Puerperal	Eritema em CUNHA/SETOR, calor e dor local	**Febre alta (> 38,5°C) + calafrios**	**MANTER RIGOROSAMENTE**	Cefalexina 500mg 6/6h 7-10d + esvaziamento
Abscesso Mamário	Massa flutuante dolente + eritema + pus	Febre persistente / refratária	**MANTER** (se distante do CAP)	Drenagem/Punção guiada + Antibiótico IV/VO
Raynaud do Mamilo	Isquemia (palidez ➔ cianose ➔ rubor)	Ausentes	**MANTER**	Calor seco local + Nifedipino se refratário

10.3 Matriz de Elegibilidade Contraceptiva no Puerpério (FEBRASGO / OMS)

Método Contraceptivo	Lactante (< 6 Semanas)	Lactante (> 6 Semanas)	Não-Lactante	Observações e Impacto na Amamentação
DIU de Cobre	Categoria 1 / 2	Categoria 1	Categoria 1	Inserção até 48h pós-parto ou após 4 semanas. Sem hormônios.
SIU-Levonorgestrel	Categoria 1 / 2	Categoria 1	Categoria 1	Inserção até 48h ou após 4 semanas. Ação predominantemente local.
Implante Etonogestrel	Categoria 1 / 2	Categoria 1	Categoria 1	Progestágeno puro. Pode ser inserido no pós-parto imediato.
Desogestrel (Minipílula)	Categoria 2	Categoria 1	Categoria 1	Progestágeno isolado. Não altera produção ou qualidade do leite.
Injetável Trimestral	Categoria 2 / 3	Categoria 1	Categoria 1	Iniciar preferencialmente após 6 semanas na lactante.
Combinados (E2 + P4)	**CATEGORIA 4 (PROIBIDO)**	**CATEGORIA 3 / 4**	Categoria 1 (após 3–6 sem)	**CONTRAINDICADO na lactação:** inibe o leite e aumenta risco de TEV.